

Profil bactériologique des pleurésies purulentes au CHU d’Annaba entre 2015 et 2025

Mots clés: Pleurésies, Entérobactéries, *Pseudomonas aeruginosa*, Résistance aux antibiotiques

A.OTMANE, A.BOUHALA, C.BOUTARFA, I.FELFLI, I.BOUNAIDJA, M.BENHARKAT, K.HACHELFI, H.BENCHERCHAR, A.BENALI, A.ADJABI, S.NEDJAI
Laboratoire central de microbiologie –Hôpital Dr Dorban- CHU d’Annaba

1. Introduction-objectif :

Les pleurésies infectieuses représentent encore actuellement un défi diagnostique et thérapeutique et demeurent grevées d’une morbi-mortalité élevée. L’évolution vers une forme compliquée pouvant être rapide et la prise en charge est **une urgence**. Le diagnostic bactériologique est indispensable pour confirmer le diagnostic, adapter l’antibiothérapie et orienter l’étiologie [1].
Le but de ce travail est d’identifier les bactéries en cause dans **les pleurésies purulentes** et d’évaluer leur sensibilité aux antibiotiques afin d’optimiser l’antibiothérapie empirique

2. Matériels et méthodes :

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive effectuée au laboratoire central de microbiologie du CHU d’Annaba incluant toutes les **ponctions pleurales** issues de patients adultes hospitalisés au service de pneumologie du CHU d’Annaba pour pleurésies infectieuses entre le **01 janvier 2015 et le 31 décembre 2025**.
Un examen cyto bactériologique (cytologie qualitative et quantitative, un examen direct et une mise en culture sur milieux enrichis) avait été appliqué à toutes les ponctions pleurales.
La réalisation et l’interprétation des résultats de l’antibiogramme avaient été faites selon les recommandations du **CLSI M-100-2026**.

3. Résultats :

Un total de 264 pleurésies purulentes avaient été colligées. Toutes les infections étaient monomicrobiennes.
Le profil bactériologique était dominé par les entérobactéries avec 43.94 % des cas devant les bacilles à Gram négatif non fermentants (21.21%) et les streptocoques (17.05%).

Répartition des espèces isolées (n=264)	
Espèces	Effectif (%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	54 (20.45)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	39 (14.77)
<i>Staphylococcus aureus</i>	32 (12.12)
<i>Escherichia coli</i>	29 (10.98)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	27 (10.23)
<i>Streptococcus anginosus group</i>	18 (06.82)
<i>Enterobacter cloacae</i>	17 (06.44)
<i>Salmonella spp</i>	16 (06.06)
<i>Citrobacter freundii</i>	08 (03.03)
<i>Enterococcus faecalis</i>	08 (03.03)
<i>Serratia marcescens</i>	07 (02.65)
<i>Haemophilus influenzae</i>	04 (01.51)
<i>Acinetobacter baumannii</i>	02 (00.76)
<i>Autres</i>	03 (01.14)

Taux de résistance aux ATB de <i>S.pneumoniae</i> (n=27)	
Antibiotique	Effectif (%)
Pénicilline G	08 (29.63)
Céfotaxime	02 (07.41)
Lévo floxacine	01 (03.70)
Vancomycine	00 (00)
Rifampicine	00 (00)
Cotrimoxazole	05 (18.52)

Taux de résistance aux ATB des Entérobactéries (n=116)	
Antibiotique	Effectif (%)
Céfotaxime	42 (36.21)
Imipénème	00 (00)
Gentamicine	38 (32.76)
Amikacine	19 (16.38)
Ciprofloxacine	52 (44.83)
Cotrimoxazole	46 (39.65)

Taux de résistance aux ATB de <i>P.aeruginosa</i> (n= 54)	
Antibiotique	Effectif (%)
Pipéracilline	12 (22.22)
Ceftazidime	05 (09.26)
Imipénème	01 (01.85)
Amikacine	03 (05.55)
Ciprofloxacine	14 (25.93)

Taux de résistance aux ATB de <i>S. aureus</i> (n=32)	
Antibiotique	Effectif (%)
Oxacilline	12 (37.50)
Gentamicine	06 (18.75)
Ciprofloxacine	04 (12.50)
Vancomycine	00 (00)
Rifampicine	00 (00)
Cotrimoxazole	02 (06.25)

4. Discussion :

Le pronostic des pleurésies purulentes est fonction de la rapidité du diagnostic étiologique et de la mise en œuvre d’une antibiothérapie adaptée [1]. **Notre profil** bactériologique largement dominé par les entérobactéries **s’opposait aux données de la littérature** qui rapportaient une nette prédominance des cocci à Gram positif et principalement des streptocoques du groupe *anginosus* [2][3].
La part du **pneumocoque** était également supérieure à nos résultats [2][4] et pouvait atteindre 40% selon Basille et al [1].
Le taux du *P.aeruginosa* était également plus important dans notre série [4][5] alors que le rôle du ***S.aureus*** se rapprochait davantage des données de la littérature [2][5].

5. Conclusion :

Notre travail rapportait une nette prédominance des bacilles à Gram négatif dans les pleurésies purulentes. L’antibiothérapie qui constitue avec l’évacuation pleurale les piliers de la prise en charge des pleurésies infectieuses doit s’adresser à ce groupe de germes lors du traitement empirique. La part du pneumocoque dans les pleurésies demeurerait faible dans notre série.
Le suivi épidémiologique régulier du profil bactériologique est à même d’adapter l’antibiothérapie empirique[1][4] .

Références :

[1] Basille D. Pleurésies infectieuses : quelles nouveautés pour le diagnostic, le pronostic et le traitement ? Revue des Maladies Respiratoires Actualités 2022 ; 14 :2S441-2S445.
[2] Corcoran J.P, Wrightson J M, Belcher E et al. Pleural infection: past, present, and future directions. Lancet Respir Med 2015; 3: 563-577.
[3] Elsheikh A, Rahman N.M, Bedawi E.O. Pleural infection. Médecine 2023 ; 51(11) : 784-790.
[4] Rachidi M, Rada N, Draiss G, Bouskraoui M, Soraa N. Le profil bactériologique des pleurésies purulentes au CHU de Marrakech.Revue Francophone des Laboratoires 2019 ; 509 : 77-80.
[5] Lehtomäki A, Nevalainen R, Ukkonen M, Nieminen J, Laurikka J, Khan J. Trends in The Incidence, Etiology, Treatment, and Outcomes of Pleural Infections in Adults Over a Decade in a Finnish University Hospital Scandinavian Journal of Surgery 2020 ; 109(2): 127-132.